

PROTOCOLO DE ACESSO PARA ULTRASSONOGRAFIA ELETIVA/ AMBULATORIAL



**JOINVILLE
2025**



MISSÃO

“Promover saúde e bem-estar para as pessoas.”



VISÃO

“Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil.”

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



SECRETÁRIA DA SAÚDE

Daniela Aparecida Gregório França Cavalcante

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Jocelita Cardozo Colagrande

DIRETORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Vanessa Cardoso Pacheco

DIRETORIA ESTRATÉGICA

Aline Gabrielle de Souza Berkenbrock

DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Amanda Nunes

DIRETORIA TÉCNICA

Luana Garcia Ferrabone

GERÊNCIAS DE DISTRITOS SANITÁRIOS

Ana Aparecida Pereira - Distrito Norte

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann - Distrito Centro

Elisarb Mirapalhete Rodrigues Vilar - Distrito Sul

Maristela Mello de Aguiar - Distrito Oeste

GERÊNCIA DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Juliana Antunes Safanelli

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL

Johnathan Curcio

GERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL

Ana Caroline Giacomini

GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Franci Maiara Machado

GERÊNCIA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA

Rayane Alexandra Prochnow

GERÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Fabiane Voss

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Jaqueline Fornari

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Flaviane Andrzejewski

NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS

Cibely Schipitoski

COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Jhoselin Paula Alves Carone Rachid

ELABORAÇÃO/COLABORAÇÃO

Jhoselin Paula Alves Carone Rachid

Nicole Schulka



INTRODUÇÃO.....	6
1. INFORMAÇÕES REFERENTE AO MÉTODO ULTRASSONOGRÁFICO.....	8
1.1. Critério de Inclusão.....	8
1.2. Critério de Exclusão.....	8
1.3. Grupos de Atenção.....	8
2. CONTRAINDICAÇÃO.....	8
3. PROFISSIONAL SOLICITANTE.....	9
3.1. Critérios para encaminhamento.....	9
3.2. Orientações ao profissional solicitante.....	9
4. CONTEÚDO DESCRITIVO MÍNIMO.....	9
5. SEGMENTOS - ULTRASSONOGRAFIA.....	10
5.1. Ultrassonografia de Mamas Bilateral.....	10
5.2. Ultrassonografia de Abdomen Total.....	11
5.3. Ultrassonografia de Abdomen Superior.....	11
5.4. Ultrassonografia de Próstata Via Abdominal e Via Transretal.....	12
5.5. Ultrassonografia do Aparelho Urinário.....	13
5.6. Ultrassonografia das Articulações.....	14
5.7. Ultrassonografia da Tireóide.....	14
5.8. Ultrassonografia Transvaginal.....	15
5.9. Ultrassonografia Pélvica - Via Abdominal.....	16
5.10. Ultrassonografia de Bolsa Escrotal.....	17
5.11. Ultrassonografia de Partes Moles (Massas, Hérnias).....	18
5.12. Ultrassonografia com Doppler Arterial - Membros Inferiores.....	19
5.13. Ultrassonografia com Doppler Venoso - Membros Inferiores.....	19
5.14. Ultrassonografia com Doppler Arterial - Membros Superiores.....	20
5.15. Ultrassonografia com Doppler Venoso - Membros Superiores.....	21
5.16. Ultrassonografia com Doppler de Carótidas e Vertebrais.....	22
5.17. Ultrassonografia com Doppler de Aorta Abdominal.....	22
5.18. Ultrassonografia com Doppler Aorta e Artérias Ilíacas.....	23
5.19. Ultrassonografia com Doppler de Artérias Renais.....	24
5.20. Ultrassonografia com Doppler Vasos Hepáticos.....	24
5.21. Ultrassonografia com Doppler Veia Cava Inferior e Vasos Ilíacos.....	25
5.22. Ultrassonografia com Doppler Transcraniano.....	26
6. PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME.....	26
7. RESULTADOS/ LAUDOS.....	26
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	27



LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

AASI - Aparelho de Amplificação Sonora Individual
ABR - Auditory brainstem response/Audiometria de tronco encefálico
ADNPM - Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor
APS - Atenção Primária à Saúde
BERA (ou **PEATE**) - Brainstem Evoked Response Audiometry/Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico
COMUSA - Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva
dB - Decibel
EOA - Emissões Otoacústicas Evocadas
HIJG - Hospital Infantil Joana de Gusmão
Hz - Unidade Hertz
IPRF - Índice Percentual de Reconhecimento de Fala
IRDA - Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva
KHz - KiloHertz
LDV - Limiar de Detecção de Voz
LRF - Limiar de Reconhecimento de Fala
NAIPE - Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo
Nº - Número
ORL - Otorrinolaringologia
PCD - Pessoa com Deficiência
PEATE - Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico
PFT - Prova da Função Tubária
PMV - Procedimento Municipal Vinculado
PSE - Programa de Saúde do Escolar
SASA - Serviço Ambulatorial de Saúde Auditiva
SC - Santa Catarina
SEI - Sistema Eletrônico de Informação
SER - Serviço Especializado em Reabilitação
SIG-SaudeTech - Sistema Integrado de Gestão
SUS - Sistema Único de Saúde
TANU - Triagem Auditiva Neonatal Universal
TDI - Transtorno do Déficit Intelectual
TDH 39 - Telephonics Dynamic Headphone Modelo 39
UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família
VRA - Audiometria de Reforço Visual
TEA - Transtorno do Espectro Autista



INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei nº 8.080/1990, garante o acesso universal, integral e equitativo às ações e serviços de saúde. A Política Nacional de Regulação, estabelecida pela Portaria GM/MS nº 1.559/2008, orienta a regulação em três dimensões: Regulação dos Sistemas de Saúde; Regulação da Atenção à Saúde e Regulação da Assistência à Saúde.

A regulação assistencial, ou regulação do acesso, consiste na disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, de forma ordenada, oportuna, qualificada e equânime, sendo um instrumento fundamental para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Por meio do processo regulatório, promove-se a resolução de casos que exigem ações articuladas em diferentes pontos de atenção, favorecendo a gestão racional dos recursos, a identificação de áreas críticas e a otimização do atendimento.

A importância do ultrassom como exame complementar na prática clínica atual já está bem definida, especialmente quando se considera a necessidade de uma abordagem racional e eficiente na solicitação de exames. O ultrassom, ou ecografia, é uma ferramenta diagnóstica que utiliza ondas sonoras para criar imagens de estruturas internas do corpo, permitindo a avaliação de diversas condições patológicas. No entanto, sua utilização deve ser pautada por uma gestão criteriosa de recursos, evitando a solicitação indiscriminada e promovendo um enfoque no exame clínico.

A racionalidade na solicitação de exames de imagem, como o ultrassom, é fundamental para garantir que os pacientes recebam o diagnóstico mais preciso e eficaz, sem a exposição desnecessária a procedimentos invasivos ou a custos excessivos. Estudos demonstram que a integração do exame clínico com a interpretação dos resultados do ultrassom pode levar a uma melhor tomada de decisão clínica, otimizando o manejo do paciente (Baker et al., 2019; Heller et al., 2020). Assim, o ultrassom deve ser visto como um complemento ao exame físico, e não como um substituto, reforçando a importância da avaliação clínica inicial detalhada na definição da necessidade do exame.

Além disso, a gestão de recursos em saúde é um aspecto crucial na prática médica atual, onde a eficiência e a eficácia dos serviços são constantemente avaliadas. A utilização adequada do ultrassom pode contribuir para a redução de custos e para a melhoria da qualidade do atendimento, ao direcionar intervenções diagnósticas e terapêuticas de forma mais assertiva (Baker et al., 2019). Portanto, ao considerar o ultrassom como um exame complementar, é essencial que os profissionais de saúde

mantenham um olhar crítico e fundamentado, priorizando sempre a saúde e o bem-estar do paciente.

E também, orientar a ação dos médicos reguladores, visando criar uma cultura em que o acesso à Atenção Especializada seja determinado por necessidades reais identificadas na Atenção Primária, após esta ter esgotado toda sua capacidade de condução do caso, mas com a consciência de que a Atenção Primária em Saúde é e sempre será a responsável pelo acompanhamento de seus usuários.



1. INFORMAÇÕES REFERENTE AO MÉTODO ULTRASSONOGRÁFICO

A ultrassonografia é um exame de imagem que permite ao médico observar determinadas estruturas internas do corpo humano. Ela funciona por meio do uso de ondas ultrassônicas de alta frequência, que ecoam dentro do corpo do paciente. A resposta desse eco é capaz de formar imagens. A maior vantagem é ser um exame não invasivo, seguro e que não utiliza radiação ionizante (como a usada no Raio-X ou na Tomografia Computadorizada). Por isso, é o método de escolha para avaliações sensíveis, como o acompanhamento gestacional.

Este método pode ser utilizado para visualizar e analisar a forma e função de órgãos, tecidos e fluxo sanguíneo, bem como para marcar ou guiar procedimentos como biópsias, punções ou acessos venosos.

1.1. Critério de Inclusão

Qualquer suspeita clínica em que a ultrassonografia é comprovadamente eficaz para o diagnóstico.

1.2. Critério de Exclusão

Os critérios de exclusão são, na verdade, limitações físicas e técnicas que tornam o exame ineficaz ou impossível de ser realizado.

1.3. Grupos de Atenção

Pacientes que apresentam desorientação e ou agitação psicomotora; neurotípicos ou neuro diversos não colaborativos durante a realização do exame.

2. CONTRAINDICAÇÃO

Não há contraindicações absolutas para a realização de uma ultrassonografia convencional. Existem possíveis condições de restrições locais ou específicas ao método ultrassonográfico.

CONTRAINDICAÇÕES LOCAIS

- Pele que apresenta tecido lesionado, feridas abertas na região de realização do exame (por exemplo queimaduras graves, erisipela);

CONTRAINDICAÇÕES ESPECÍFICAS

- Ultrassonografia Transvaginal é contraindicado para mulheres que não iniciaram a vida sexual. Nesses casos, realiza-se o ultrassom pélvico via abdominal (bexiga cheia) ou, em casos raros e necessários, via transretal.
- Ultrassonografia Transretal é contraindicado quando presença de hemorroidas trombosadas; pós-operatório recente e estenose anal.

3. PROFISSIONAL SOLICITANTE

Paciente com endereço comprovado na macrorregião; Não sendo possível realizar diagnóstico através de outros métodos de imagem como radiografias; Pré e pós operatório; Recomendações do Ministério da Saúde de acordo com faixa etária; Necessário indicação clínica detalhada.

3.1. Critérios para encaminhamento

Profissional médico que compõem a rede de atenção à saúde pública do município de Joinville.

3.2. Orientações ao profissional solicitante

As solicitações de ultrassonografia a nível ambulatorial deverão ocorrer através no sistema Saude Tech - Olostech dentro do prontuário eletrônico na aba “Pedidos”, no item “Requisição de Procedimentos”. Em nova janela preencher CID e no campo “Pesquisar Procedimento” buscar pelo exame que deseja solicitar ex: ULTRASSONOGRRAFIA. Abrirá lista dos segmentos disponíveis, selecionar o desejado e após selecionar “Condição Importante” e preencher os campos “Justificativa” e “Dados Clínicos para este Pedido”. Todas as abas referente a solicitação do exame devem ser preenchidas obrigatoriamente.

Importante: No campo “Dados Clínicos para este Pedido” deve conter as informações solicitadas no próximo tópico deste documento “**CONTEÚDO DESCRITIVO MÍNIMO**”.

4. CONTEÚDO DESCRITIVO MÍNIMO

Indicação Clínica: principal motivo para solicitação do exame.

História Clínica: Comorbidades que possam indicar ou contraindicar a realização do exame, tratamentos prévios (cirurgias, quimioterapia, radioterapia, etc), existência de metais no corpo; informação de alergia, história sucinta com tempo de evolução (data do início e detalhar a história e evolução do quadro) informando se há motivos clínicos para



marcação em alta prioridade (categoria de priorização, de acordo com as tabelas de classificação de risco deste protocolo);

Exame Físico: Descrever os achados relevantes e a presença de complicações ou doenças associadas, bem como uso de medicações que possam indicar ou contraindicar a realização do exame;

Exames Complementares Prévios: Descrever laudos de exames anteriores relacionados à região a ser examinada (TC, RM, RX, exame do líquido se doença infecciosa), ou se disponíveis levar os mesmos no dia da realização do exame.

Hipótese Diagnóstica: Descrever hipótese diagnóstica no pedido médico.

Importante: Para os exames com finalidade de laudo comparativo **é obrigatório** que sejam levados os laudos anteriores.

5. SEGMENTOS - ULTRASSONOGRAFIA

5.1. Ultrassonografia de Mamas Bilateral

Critérios:

- Mamografia BI-RADS 0, III, IV, V ou VI na presença de imagem nodular (alteração na arquitetura, simetria). No caso de MMG BI-RADS 0 descrever o local e a alteração identificada previamente;
- Identificar e caracterizar anormalidades palpáveis no exame físico (nódulos, tumores);
- Avaliar problemas associados a implantes mamários; e
- Massas palpáveis em mulheres com idade < 35 anos.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico da mama e presença ou não de complicações ou doenças associadas.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 01. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS BILATERAL.

CÂNCER/SUSPEITO	Mamografia BI-RADS IV, V ou V na presença de imagem nodular.
P1	Mamografia BI-RADS 0 ou III, identificar e caracterizar anormalidades palpáveis no exame físico (nódulos e tumores), massas palpáveis em mulheres com idade abaixo de 35 anos, imagem suspeita em mamografia de pacientes com idade igual ou inferior a 35 anos.
P2	
P3	Avaliar problemas associados com implantes mamários.



5.2. Ultrassonografia de Abdome Total

Critérios:

- Investigação de dor abdominal;
- Investigação de dor pélvica crônica;
- Lesões tumorais (císticas e sólidas);
- Aneurismas;
- Colelitíase;
- Hepatoesplenomegalia; e
- Pancreatopatias.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 02. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAMA DE ABDOME TOTAL.

CÂNCER/SUSPEITO	Lesões tumorais (císticas e sólidas), aneurismas.
P1	Dor abdominal atípica, colelitíase sintomática, investigação de hepatoesplenomegalia.
P2	Investigação de dor abdominal e dor pélvica crônica.
P3	Acompanhamento de lesões benignas, controle de lesões pancreáticas/abdominais/biliares.

5.3. Ultrassonografia de Abdome Superior

Critérios:

- Investigação de dor abdominal;
- Lesões tumorais (císticas e sólidas);
- Colelitíase;
- Investigação de esteatose hepática;
- Pólipos de vesícula biliar;
- Hepatoesplenomegalia;
- Pancreatopatias;
- Investigação de alterações laboratoriais hepáticas/pancreáticas;
- Controle de lesões pancreáticas: cistos, nódulos, pancreatite crônica;
- Controle de lesões hepáticas/biliares/abdominais: cistos, nódulos benignos, esteatose hepática; e

- Rastreamento de hepatocarcinoma em portadores de cirrose hepática.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico da mama e presença ou não de complicações ou doenças associadas.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 03. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR.

CÂNCER/SUSPEITO	Lesões tumorais (císticas e sólidas), aneurismas.
P1	Dor abdominal atípica, colelitíase sintomática, investigação de hepatoesplenomegalia, rastreamento de hepatocarcinoma em portadores de cirrose hepática.
P2	Investigação de dor abdominal, investigação de alterações laboratoriais hepáticas/pancreáticas.
P3	Controle de lesões pancreáticas/abdominais/biliares.

5.4. Ultrassonografia de Próstata Via Abdominal e Via Transretal

Critérios:

- Suspeita de câncer prostático
- Hiperplasia prostática benigna (HPB);
- Prostatite;
- Infertilidade;
- Abscesso;
- Prostatismo;
- PSA alterado;

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Importante: Informar laudo de exames anteriores, USG anterior com data e laudo, PSA, PSA livre, se houver.

QUANDO SOLICITAR ULTRASSOM DE PRÓSTATA VIA TRANSRETAL?

- Prostatismo, em pacientes com obesidade grau III (IMC > 40 kg/m²) com exame digital prostático alterado na suspeita de Carcinoma de Próstata.

Quadro 04. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA VIA ABDOMINAL OU VIA TRANSRETAL.

CÂNCER/SUSPEITO	Tumores, controle de abscesso.
P1	Prostatite, prostatismo.
P2	PSA elevado.



P3	HPB, infertilidade.
-----------	---------------------

5.5. Ultrassonografia do Aparelho Urinário

Realizar em pacientes com história de DRC familiar, infecção urinária de repetição e doenças urológicas. (MS, acesso em 29/09/2025).

Critérios:

- Suspeita de tumores;
- Controle de nódulos / cistos renais complexos (Paredes espessas e irregulares; Septo espesso ou com realce no interior da massa; Realce da massa após a injeção de contraste; Massa multilocular; Cisto Bosniak IIF);
- Litíase;
- Malformação;
- Rim policístico;
- Insuficiência renal confirmada (CKDEPI < 30);
- Suspeita de hipertensão arterial sistêmica renovascular; e
- ITU de repetição (ocorrência de dois episódios de ITU em seis meses ou três nos últimos 12 meses.);

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas.

Importante: Informar laudo de exames anteriores: USG anterior com data e laudo, PU, função renal, se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 05. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO.

CÂNCER/SUSPEITO	Tumores, insuficiência renal (CKDEPI <30), hidronefrose.
P1	Controle de nódulos/ cistos renais complexos, malformação, litíase sintomática, suspeita de HAS renovascular, insuficiência renal (CKDEPI <45)
P2	ITU de repetição, suspeita de nefrolitíase.
P3	Rim policístico.



5.6. Ultrassonografia das Articulações

Critérios:

- Artrite séptica;
- Tendinites;
- Cistos sinoviais;
- Lesão por esforço repetitivo (LER);
- Derrames articulares;
- Bursites;
- Espessamento de bainha tendinosa de qualquer natureza; e
- Lesão muscular e tendinosa.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Importante: Solicitar um procedimento para cada área/segmento. Informar laudo de exames anteriores: RX, RNM, USG, se houver.

Quadro 06. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRRAFIA DAS ARTICULAÇÕES.

CÂNCER/SUSPEITO	Artrite séptica.
P1	Derrames articulares, doenças reumatológicas de base.
P2	Dor aguda com história de trauma recente.
P3	Tendinites, cistos sinoviais, lesão por esforço repetido, bursites, espessamento de bainha tendinosa de qualquer natureza.

5.7. Ultrassonografia de Tireóide

Critérios:

- Hipertireoidismo;
- Nódulos de tireóide;
- Cistos;
- Bócio;
- Tumores.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Importante: Informar laudo de exames anteriores: exames laboratoriais (TSH, T4L); realizar teleconsultoria com endocrinologia para auxílio na investigação, se houver.

Indicação doppler de tireóide:

- Avaliação de nódulos palpáveis e de processos inflamatórios sob o ponto de vista morfológico e padrão de vascularização, respectivamente do nódulo e do parênquima.

Quadro 07. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE.

CÂNCER/SUSPEITO	Tumores, nódulo suspeito de neoplasia.
P1	Hipertireoidismo
P2	Cistos.
P3	Bócio, controle de nódulos Bethesda I, II e III.

5.8. Ultrassonografia Transvaginal

Critérios:

- Dor pélvica aguda e crônica;
- Anexites;
- Investigação de massa abdominal;
- Diagnóstico diferencial de tumores pélvicos;
- Sangramento vaginal pós-menopausa;
- Sangramento vaginal anormal na menacme;
- Supervisão de DIU;
- Amenorréia primária;
- Amenorréia secundária não relacionada à gestação;
- Tumores e cistos ovarianos pré e pós menopausa; e
- Avaliação periódica com USG TV anual em: mulheres em uso de terapia hormonal/ mulheres em uso de tamoxifeno / IMC > 30 / antecedente de hiperplasia endometrial.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 08. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL.

CÂNCER/ SUSPEITO	Dor pélvica aguda, investigação de massa abdominal, diagnóstico diferencial de tumores pélvicos, gestação tubária.
P1	Sangramento anormal no menacme, pós menopausa ou pós inserção de DIU, gestação do 1º trimestre.
P2	Amenorréia primária, amenorréia secundária não relacionada à gravidez.
P3	Dor pélvica crônica, tumores e cistos ovarianos pré e pós menopausa.

5.9. Ultrassonografia Pélvica - Via Abdominal

Critérios:

- Dor pélvica aguda e crônica;
- Anexites;
- Investigação de massa abdominal;
- Diagnóstico diferencial de tumores pélvicos;
- Sangramento vaginal pós-menopausa;
- Sangramento vaginal anormal na menacme;
- Supervisão de DIU / sangramento após inserção de DIU;
- Amenorréia primária;
- Amenorréia secundária não relacionada à gestação;
- Tumores e cistos ovarianos pré e pós menopausa; e
- Miomas uterinos volumosos.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 09. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA - VIA ABDOMINAL.

CÂNCER/SUSPEITO	Dor pélvica aguda, investigação de massa abdominal, diagnóstico diferencial de tumores pélvicos.
P1	Sangramento anormal no menacme, pós menopausa ou pós inserção de DIU, miomas uterinos volumosos.
P2	Amenorréia primária, amenorréia secundária não relacionada à gravidez.



P3	Dor pélvica crônica, tumores e cistos ovarianos pré e pós menopausa.
-----------	--

Importante: O exame é utilizado na investigação de patologias ginecológicas para pacientes com hímen íntegro (sem ter iniciado atividade sexual), atrofia genital importante, crianças, adolescentes, ou qualquer outra condição que impossibilite o exame via transvaginal. Possui as mesmas indicações da ultrassonografia transvaginal, incluindo:

- Necessidade de avaliação do DIU (no caso de inserção difícil, como em pacientes com útero retrovertido, adenomiose, obesidade, ou na suspeita de posição anômala, quando o fio não é visualizado no exame especular);
- A puberdade precoce é definida como o início do desenvolvimento de caracteres secundários (telarca, pubarca) antes do limite inferior de idade considerado, ou seja, antes dos oito anos de idade para as meninas.
- A puberdade é considerada atrasada nas meninas quando não ocorre desenvolvimento das mamas até os 13 anos de idade.

5.10. Ultrassonografia de Bolsa Escrotal

Critérios:

- Aumento de volume da bolsa escrotal;
- Tumores;
- Varicocele;
- Cistos de cordão; e
- Controle de infecções ou de torção do testículo.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Indicação de USG doppler de bolsa escrotal:

- Padrão de vascularização do testículo, epidídimo, cordão espermático e bolsa e parede da bolsa escrotal;
- Suspeita de varizes na bolsa escrotal;
- Acompanhar resposta a quimioterapia de tumor testicular.

Quadro 10. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL.

CÂNCER/SUSPEITO	Tumores, dor escrotal aguda.
P1	Controle de infecções ou torção de testículo.

P2	Aumento de volume da bolsa escrotal, suspeita de criptorquidia em criança > 1 ano.
P3	Varicocele, cistos de cordão.

5.11. Ultrassonografia de Partes Moles (Massas/ Hérnias)

Critérios:

- Avaliação e acompanhamento da profundidade de tumores cutâneos e subcutâneos;
- Avaliação e investigação de hérnias;
- Avaliação de parede abdominal (hérnias incisionais, diástase); e
- Avaliação e investigação de linfonodomegalia.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico detalhado e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Se avaliação de parede abdominal:

- Nodulação palpável / aumento de volume
- Suspeita de hérnias da parede abdominal (hérnias umbilicais, epigástricas, incisionais)
- Complicações pós-operatórias com celulite, abscesso ou hematoma.

Se avaliação de região inguinal:

- Deve constar na solicitação o lado para realização do exame.
- Suspeita de hérnia inguinal direta, indireta ou femoral
- Massa ou adenomegalia inguinal
- Pesquisa de testículos ectópicos
- Avaliação de coleções

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 11. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRRAFIA DE PARTES MOLES (MASSAS/ HÉRNIAS).

CÂNCER/SUSPEITO	Suspeita de lesões tumorais.
P1	Abscesso, traumas, corpo estranho, hematoma, herniações.
P2	Acompanhamento de lesões.
P3	Lesões benignas.



5.12. Ultrassonografia com Doppler Arterial de Membros Inferiores

Critérios:

- Pacientes com suspeita de doença arterial obstrutiva periférica (DAOP): claudicação intermitente, redução de pulsos e temperatura e pacientes com fatores de risco (diabetes, tabagismo, obesidade, HAS, idade avançada);
- Pacientes com pé diabético;
- Pacientes com suspeita de oclusão arterial aguda (embolia/trombose);
- Pacientes com suspeita de aneurismas arteriais de vasos dos membros inferiores (massas pulsáteis);
- Paciente com traumatismo de membros inferiores e lesão vascular associada;
- Avaliação pós-operatória de tratamento cirúrgico ou endovascular de revascularização de membros inferiores; e
- Avaliação para realização e acompanhamento de fístula arteriovenosa para diálise;

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso e exame físico detalhado com dados como: pressão arterial, ausculta cardíaca, descrição dos pulsos, presença de lesões cutâneas, edema, diminuição de temperatura, claudicação intermitente. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 12. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES.

CÂNCER/SUSPEITO	Suspeita de oclusão arterial aguda, traumatismo de membros inferiores com lesão vascular associada.
P1	Pacientes com pé diabético, pacientes com suspeita de aneurismas arteriais de vasos dos membros inferiores
P2	Pacientes com suspeita de doença arterial obstrutiva periférica (DAOP), avaliação pós-operatória de tratamento cirúrgico ou endovascular de revascularização de membros inferiores, avaliação para realização e acompanhamento de fístula arteriovenosa para diálise.
P3	

5.13. Ultrassonografia com Doppler Venoso de Membros Inferiores

Critérios:

- Pacientes com varizes de membros inferiores;
- Pacientes com sinais de insuficiência venosa crônica;
- Pacientes com suspeita de trombose venosa profunda nos membros inferiores;
- Pacientes com quadro clínico de tromboflebite;
- Avaliação pré-operatória para cirurgia de tratamento de varizes; e
- Avaliação para realização e acompanhamento de fístula arteriovenosa para diálise.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso e exame físico detalhado com dados como: pressão arterial, ausculta cardíaca, descrição dos pulsos, presença de lesões cutâneas e úlceras, edema, empastamento das panturrilhas, presença de dor e suas características. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 13. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES.

CÂNCER/SUSPEITO	Pacientes com suspeita de trombose venosa profunda nos membros inferiores.
P1	Pacientes com quadro clínico de tromboflebite.
P2	Pacientes com varizes de membros inferiores, pacientes com sinais de insuficiência venosa crônica, avaliação pré-operatória para cirurgia de tratamento de varizes, avaliação para realização e acompanhamento de fístula arteriovenosa para diálise.

5.14. Ultrassonografia com Doppler Arterial - Membros Superiores

Critérios:

- Síndrome de compressão da Subclávia;
- Trombose Arterial Aguda;
- Embolia;
- Hemangioma; e
- Traumatismo com pressão ou lesão vascular.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso, história de eventos prévios e exame físico detalhado com dados como: pressão arterial, ausculta cardíaca, descrição dos pulsos. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 14. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS SUPERIORES.

CÂNCER/SUSPEITO	Oclusão arterial aguda (trombose ou embolia); Aneurisma e pseudo-aneurisma; Trauma com lesão vascular; Fístulas arteriovenosas para hemodiálise.
P1	Arterite; Hemangioma; Malformações vasculares; Síndrome do desfiladeiro cérvico torácico; Parestesia (suspeita de doença vascular);
P2	Segmentos

5.15. Ultrassonografia com Doppler Venoso - Membros Superiores

Critérios:

- Edema;
- Fístulas Arteriovenosas;
- Hemangioma; e
- Trombose Venosa.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso, história de eventos prévios e exame físico detalhado com dados como: pressão arterial, ausculta cardíaca, descrição dos pulsos. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 15. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBROS SUPERIORES.

CÂNCER/SUSPEITO	Trombose venosa profunda; Tromboflebite; Fístulas arteriovenosas para hemodiálise (mapeamento pré e pós-operatório);
P1	Edema de membros superiores; Hemangioma; Suspeita de compressão extrínseca (síndrome do desfiladeiro); Traumas;
P2	Segmentos

5.16. Ultrassonografia com Doppler de Carótidas e Vertebrais

Critérios:

- Pacientes com suspeita de doença carotídea (obstrução por aterosclerose);
- Pacientes com quadro clínico de acidente vascular encefálico (AVE/AVC) ou acidente isquêmico transitório (AIT);
- Investigação de síncope;



- Investigação de massa pulsátil cervical; e
- Avaliação pré-operatória para cirurgia de artérias carótidas.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso, história de AVC/AIT prévios e exame físico detalhado com dados como: pressão arterial, ausculta cardíaca, descrição dos pulsos. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 16. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS.

CÂNCER/SUSPEITO	Pacientes com quadro clínico de acidente vascular encefálico (AVE/AVC) ou acidente/ataque isquêmico transitório (AIT).
P1	Investigação de síncope, investigação de massa pulsátil cervical.
P2	Pacientes com suspeita de doença carotídea, avaliação pré-operatória para cirurgia de artérias carótidas.

5.17. Ultrassonografia com Doppler de Aorta Abdominal

Critérios:

- Angina;
- Massa Pulsátil;
- Sopro Abdominal;
- Aneurisma; e
- Dissecção Aórtica.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso, história de eventos prévios e exame físico detalhado com dados como: pressão arterial, ausculta cardíaca, descrição dos pulsos. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 17. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE AORTA ABDOMINAL.

CÂNCER/SUSPEITO	Doença arterial obstrutiva (dor isquêmica em repouso); Doenças não ateroscleróticas (Dissecção aórtica, Doença de Takayasu, Displasia fibromuscular, Fístulas arteriovenosas); Aneurisma, Massa Pulsátil; Síndrome do dedo azul (embolia arterial);
P1	Claudicação intermitente; Síndrome de Leriche; Sopro abdominal; Avaliação pós-tratamento cirúrgico ou endovascular



	(enxerto, endoprótese);
P2	Segmentos;

5.18. Ultrassonografia com Doppler Aorta e Artérias Ilíacas

Critérios:

- Diagnóstico e acompanhamento de aneurismas e pseudo aneurismas de aorta abdominal (AAA) e artérias ilíacas;
- Avaliação pós-operatória de correção endovascular ou aberta de aneurismas;
- Avaliação da doença aterosclerótica;
- Dissecção; e
- Arterites.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso, história de eventos prévios e exame físico detalhado com dados como: pressão arterial, ausculta cardíaca, descrição dos pulsos. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 18. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS ILÍACAS.

CÂNCER/SUSPEITO	Doença arterial obstrutiva (dor isquêmica em repouso); Doenças não ateroscleróticas (Dissecção aórtica, Doença de Takayasu, Displasia fibromuscular, Fístulas arteriovenosas); Aneurisma, Massa Pulsátil; Síndrome do dedo azul (embolia arterial);
P1	Claudicação intermitente; Síndrome de Leriche; Sopro abdominal ou femoral; Avaliação pós-tratamento cirúrgico ou endovascular (enxerto, endoprótese);
P2	Segmentos;

5.19. Ultrassonografia com Doppler de Artérias Renais

Critérios:

- Hipertensão Renovascular;
- Tumores renais e suprarrenais; e
- Avaliação e acompanhamento de transplante renal.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso, história de eventos prévios e

exame físico detalhado com dados como: pressão arterial, ausculta cardíaca, descrição dos pulsos. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 19. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAIIS.

CÂNCER/SUSPEITO	Hipertensão renovascular; Tumores renais e suprarrenais; Avaliação de transplante renal;
P1	Avaliação de recém-nascido com diagnóstico de hidronefrose antenatal;
P2	Acompanhamento de transplante renal;

5.20. Ultrassonografia com Doppler Vasos de Hepáticos

Critérios:

- Hipertensão portal associada à cirrose;
- Trombose da veia porta ou hepática;
- Vascularidade das lesões focais hepáticas;
- Acompanhamento após TIPS ou transplante de fígado; e
- Medição da permeabilidade das veias e artérias hepáticas, velocidade e direção do sangue.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso, história de eventos prévios e exame físico detalhado com dados como: pressão arterial, ausculta cardíaca, descrição dos pulsos. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 20. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VASOS HEPÁTICOS.

CÂNCER/SUSPEITO	Trombose da veia porta ou hepática, hipertensão portal associada à cirrose
P1	Vascularidade das lesões focais hepáticas
P2	Acompanhamento após TIPS ou transplante de fígado
P3	Medição da permeabilidade das veias e artérias hepáticas, velocidade e direção do sangue



5.21. Ultrassonografia com Doppler de Veia Cava Inferior e Vasos Ilíacos

Critérios:

- Investigação de trombose venosa, sobretudo na avaliação de eventual extensão de trombose venosa profunda (TVP) de membros inferiores e pelve para a VCI; e
- Avaliação pós-operatória de filtro de VCI.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso, história de eventos prévios e exame físico detalhado com dados como: pressão arterial, ausculta cardíaca, descrição dos pulsos. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 21. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VEIA CAVA INFERIOR E VASOS ILÍACOS.

CÂNCER/SUSPEITO	Investigação de trombose venosa
P1	Avaliação pós-operatória de filtro de VCI
P2	

5.22. Ultrassonografia com Doppler Transcraniano

Indicação clínica bem delimitada em literatura:

Pacientes com diagnóstico de Doença Falciforme entre 2 e 16 anos (CID 10 – D57.0, D57.1, D57.2, D57.3 e D 57.8).

6. PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME

O preparo para realização do exame é orientado pelo prestador do serviço ao usuário.

7. RESULTADOS/ LAUDOS

Os laudos devem ser retirados pelo usuário ou representante legal do mesmo, conforme orientação do prestador do exame. Respeitando a LGPD.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baker, J. et al. (2019). "The Role of Ultrasound in Clinical Practice: A Review." *Journal of Clinical Medicine*.

Heller, M. et al. (2020). "Integrating Clinical Examination and Imaging: A New Paradigm." *British Medical Journal*.

SAÚDE, Secretaria de Estado da. PROTOCOLOS DE ACESSO DA REGULAÇÃO ESTADUAL AMBULATORIAL SES/SC ULTRASSONOGRAFIAS. Disponível em: https://www.saude.sc.gov.br/edocman/legislacao/legislacao-geral/anexos-das-deliberacoes/anexos-deliberacoes-2017/anexos-deliberacao-115-2017_copy_copy_copy/ANEXO%20DELIBERA%C3%87%C3%83O%20185-2017-%20PROTOCOLO%20-%20ULTRASSONOGRAFIAS.pdf. Acesso em: 29 set. 2025.

CURITIBA, SES-. PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E PÉLVICA GINECOLÓGICA. Disponível em: <https://saude.curitiba.pr.gov.br/images/Protocolo%20ultrassonografia.pdf>. Acesso em: 29 set. 2025.

LAGES, Prefeitura do Município de Lages – Sc Secretaria Municipal da Saúde do Município de. PROTOCOLOS DE REGULAÇÃO PARA ACESSO À ULTRASSONOGRAFIA. Disponível em: <https://saudelages.sc.gov.br/files/protocolo/1/20191002085820.pdf>. Acesso em: 30 set. 2025.

ANDRÉ, Secretária Municipal de Saúde, Prefeitura Santo. PROTOCOLO DE REGULAÇÃO. Disponível em: <https://portais.santoandre.sp.gov.br/saude/wp-content/uploads/sites/30/2025/06/PROTOCOLO-DE-ACESSO-EXAMES-APROVADO.pdf>. Acesso em: 30 set. 2025.

MULHER, Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto Departamento de Planejamento em Saúde Coordenadoria de Assistência Integral à Saúde da. **PROTOCOLO DE ATENÇÃO ÀS MULHERES NO CLIMATÉRIO E MENOPAUSA.** Disponível em: https://more.ufsc.br/homepage/inserir_homepage. Acesso em: 30 set. 2025.

LOOMIS, A.; CHAKKO, M. Doppler Trans-Cranial Assessment, Protocols, and Interpretation. StatPearls Publishing, 2024 Jan.
(referencia: <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/saude658202212.pdf>)

